

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

Γενικά: Το σύνδρομο συμπίεσης νωτιαίου μυελού (ΣΣΝΜ) είναι μια επείγουσα ογκολογική κατάσταση που εμφανίζεται στο 4-10% όλων των καρκινοπαθών και στο 40% των ασθενών με γνωστές οστικές μεταστάσεις. Η συχνότητα του ΣΣΝΜ αυξάνεται, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των εξελιγμένων διαγνωστικών μεθόδων και επειδή οι ασθενείς με καρκίνο ζουν περισσότερο, λόγω της έγκαιρης ανίχνευσης και των βελτιωμένων θεραπειών.

Αιτία: Το ΣΣΝΜ προκαλείται από καθίζηση ενός σπονδυλικού σώματος ή τη συμπίεση από οστική μάζα η οποία αποτελεί μεταστατική εστία ή οφείλεται σε άμεση επέκταση του όγκου στη ΣΣ. Το ΣΣΝΜ συχνότερα προκαλείται από μεταστατικά νεοπλάσματα πνεύμονα (25%), προστάτη (16%), μαστού (10%), νεφρού (7%), πολλαπλό μυέλωμα (11%), σαρκώματα των μαλακών μορίων ή των οστών, λεμφώματα (*Hodgkin και non-Hodgkin*) και σπανιότερα από ενδομυελικές μάζες (π.χ. *νευρίνωμα, μηνιγγίωμα, επενδύωμα, αστροκύτωμα*).

Κλινική εικόνα: Το ΣΣΝΜ χαρακτηρίζεται από την προοδευτική εισβολή νευρολογικής συμπτωματολογίας και την παρουσία διαταραχών αισθητικότητας κατά την κλινική εξέταση. Αποτελεί επείγουσα κατάσταση διότι - χωρίς θεραπευτική αγωγή - εξελίσσεται ταχέως λόγω της νευρωνικής ισχαιμίας και μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη αναπηρία τον πάσχοντα, τόσο κινητική όσο και με ανεπάρκεια των σφιγκτήρων και απώλεια τενόντιων αντανακλαστικών. Διαγνωστικά, εκτός από την πλήρη νευρολογική εξέταση, θα χρειαστεί απεικόνιση της ΣΣ με CT ή/και MRI, επικεντρωμένη στο ύποπτο επίπεδο της βλάβης (*συνήθως ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ*).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Κύριο μέλημα είναι η σταθεροποίηση του ασθενούς και η αξιολόγηση των A-B-C-D-E.
2. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂, T°C*). Διενεργείται ΗΚΓφικός έλεγχος και επί διαταραχών του ρυθμού ο ασθενής τίθεται υπό συνεχές monitoring.
3. Επί δύσπνοιας εκτελείται βρογχοδιαστολή με *Berovent / Pulmicort*, με ροή O₂ στα 6 lt/min ή χορηγείται O₂ με μάσκα Venturi (35-40%) με ροή 8-12 lt/min, με στόχο SpO₂ > 90-92%.
4. Τοποθετείται ευρεία φλεβική γραμμή και λαμβάνονται: γενική αίματος, β/χ έλεγχος: *Glu, Urea, Creat, UA, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, CRP, AST/ALT, ALP, CPK, INR, aPTT, D-dimers, κ.λπ.*
5. Χορηγούμε κρυσταλλοειδή: 1000 ml NaCl 0,9% ή R/L, αργά στάγδην, για υποστήριξη.
6. Επί έντονου ή μη ανεκτού άλγους, χορηγείται αναλγησία με ΜΣΑΦ και Παρακεταμόλη. Έτσι, χορηγείται 1 fl. *Combogesic* 100 ml (iv) και 1 amp. *Musco-Ril* (im). Εναλλακτικά, χορηγούμε 1 amp. *Dynastat* 40 mg (ή 1 amp. *Viaxal* 50 mg) εντός 100-250 ml N/S, μαζί με 1 fl. 100 ml Παρακεταμόλη 1 gr (*Apotel*) [iv], ή ενίεται 1 amp. *Voltaren* 75 mg μαζί με 1 amp. *Apotel-plus* (im). Επί αφόρητου άλγους, μετά από παρέλευση 30-60 λεπτών ή ευθύς εξ αρχής, χορηγούνται 1 amp. Τραμαδόλη 100 mg (*Tramal*) σε 100 ml NaCl 0,9% εντός 20-30 λεπτών (iv) ή 1 amp. Πεθιδίνη ή 1 amp. Δεξτροπροποξυφαίνη (im).
7. Χορηγείται Δεξαμεθαζόνη: 1 amp. Dexamethasone 4 mg (iv ή im), ανά 6 ώρες.
8. Για γαστροπροστασία: 2 amp. Σιμετιδίνη 200 mg (στάγδην) ή 1 amp. PPI's x 2 (iv bolus).
9. Η έγχυση κορτικοστεροειδών στον επισκληρίδιο χώρο [*epidural steroids injections - ESI*] επιχειρείται από ειδικό, για ανακούφιση από το οίδημα, τη φλεγμονή και τη νευρολογική δυσλειτουργία που προκαλεί το ΣΣΝΜ. Για παρατεταμένη δράση: Dexamethasone 4 mg, ενώ για άμεση ανακούφιση: Hydrocortisone 500 mg, αμότερα σε εφάπαξ έγχυση.
10. Τοποθετείται καθετήρας Foley (14-16 fr), προς αποσυμφόρηση της ουροδόχου κύστης και για τη μέτρηση των αποβαλλόμενων ούρων, που πρέπει να κυμαίνονται στα 4-6 ml/kg/h.
11. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για θρομβοεμβολικό επεισόδιο, χορηγείται προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή: ήτοι: Enoxaparin (*Clexane*) 1 mg/kg ή Tinzaparin (*Innohep*) 4500 iu ή Fondaparinux (*Arixtra*) 7,5 mg για ΒΣ: 60-100 kg, όλα άπαξ (1x1) ημερησίως (υποδόρια).
12. Λαμβάνονται οδηγίες από τον ογκολόγο - ιατρό του ασθενούς, σχετικά με την περαιτέρω παρηγορική φροντίδα και την ανάγκη ή όχι διακομίδης (σε ασθενείς τελικού σταδίου).